· 国医国药 ·

# 舌咽四步针法对缺血性脑卒中后构音障碍患者言语功能的影响分析

张祥军　刘开明　郭虎军　张鑫　王玕

【摘要】 **目的**　观察舌咽四步针法对缺血性脑卒中后构音障碍患者言语功能的影响。**方法**　选取100例缺血性脑卒中后构音障碍患者作为研究对象，随机分为治疗组和对照组，每组50例。两组患者均采用内科基础治疗，对照组采用常规针刺（体针）治疗，治疗组采用舌咽四步针法治疗。比较两组患者构音障碍严重程度及治疗后言语功能评分。**结果**　治疗后，治疗组言语功能评分为16~28分，平均言语功能评分为(26.2 ± 2.4)分；对照组言语功能评分为9~28分，平均言语功能评分为(19.7 ± 5.0)分。治疗后，两组患者言语功能评分均明显高于本组治疗前，且治疗组言语功能评分高于对照组，差异有统计学意义($P$<0.01)。治疗组构音障碍严重程度轻于对照组，差异有统计学意义($P$<0.01)。**结论**　舌咽四步针法可有效改善缺血性脑卒中后构音障碍患者言语功能，缓解病情，值得推广。

【关键词】 舌咽四步针法；针刺治疗；缺血性脑卒中；构音障碍；言语功能

DOI：10.14163/j.cnki.11-5547/r.2023.23.029

**Analysis of the influence of tongue-pharynx four-step acupuncture on speech function in patients with dysarthria after ischemic stroke**

*ZHANG Xiang-jun, LIU Kai-ming, GUO Hu-jun, et al. Bijie Hospital of Traditional Chinese Medicine, Bijie 551700, China*

【**Abstract**】 **Objective**　To observe the influence of tongue-pharynx four-step acupuncture on speech function in patients with dysarthria after ischemic stroke. **Methods**　A total of 100 ischemic stroke patients with dysarthria were randomly divided into a treatment group and a control group, with 50 cases in each group. Both groups were treated with basic medical treatment. On this basis, the control group was treated with conventional acupuncture (body acupuncture), and the treatment group was treated with tongue-pharynx four-step acupuncture. The severity of dysarthria and the score of speech function after treatment were compared between the two groups. **Results**　After treatment, the speech function scores of the treatment group was 16-28 points, with an average of (26.2 ± 2.4) points; the speech function score of the control group was 9-28 points, with an average of (19.7 ± 5.0) points. After treatment, the speech function score in both groups was significantly higher than that before treatment in this group, and the speech function score in the treatment group was higher than that in the control group. The differences were statistically significant ($P$<0.01). The severity of dysarthria in the treatment group was milder than that in the control group, and the difference was statistically significant ($P$<0.01). **Conclusion** Tongue-pharynx four-step acupuncture can effectively improve the speech function of patients with dysarthria after ischemic stroke, alleviate the disease, and is worthy of promotion.

【**Key words**】 Tongue-pharynx four-step acupuncture; Acupuncture treatment; Ischemic stroke; Dysarthria; Speech function

构音障碍是脑卒中后发生延髓麻痹而出现的主要症状之一，脑卒中患者出现构音障碍的发生率为30%~40%。根据相关统计数据表明，我国缺血性及出血性中风病患者中70%~75%会出现言语功能障碍，而构音障碍则是言语功能障碍中较为常见的一种。构音障碍主要是因为患者的言语发生的构音器官由于神经、肌肉因功能障碍而发生器质性病变，从而出现构音器官的肌肉无力、功能瘫痪或其运动不协调，出现功能障碍，导致这类患者发声、发音和吐字不清等言语功能障碍的现象，构音障碍的严重程度和构音器官的神经肌肉受损程度呈正相关。这类患者发生功能障碍后主要表现为说话缺乏音量控制，吐字模糊不清，音调缓慢延长等，极大程度地影响了脑卒中后构音障碍患者的日常沟通能力和生活能力[1]，造成患者卒中后精神

基金项目：毕节市科技局联合基金项目（项目编号：毕科联合字［2018］10号）
作者单位：551700　毕节市中医医院
通讯作者：刘开明

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

心理障碍，极大增加了康复负担和经济压力。因此，脑卒中后构音障碍患者的及时干预和治疗具有很重要的意义，然而脑卒中后构音障碍患者一般通过药物治疗的疗效很差或无效，目前的治疗手段主要通过针刺治疗和言语康复训练恢复部分言语功能，特别是近年来针刺治疗报道效果比较明显。针刺治疗的取穴多数选取靠近构音器官附近的穴位，如舌、咽喉及口腔周围，在针刺治疗脑卒中后构音障碍的经验效穴中，多数为金津、玉液、廉泉，舌部穴如舌下穴、舌面部穴及舌根等[2,3]。本研究采用舌咽四步针法治疗缺血性脑卒中后构音障碍患者的效果，均在构音器官附近的咽后壁、舌面、金津、玉液、上廉泉等处选取穴位，操作简便，无副作用，患者接受度高，治疗周期短，现报告如下。

## 1 资料与方法

**1.1** 一般资料 选取2019年11月~2021年8月毕节市中医医院脑病科收治的100例缺血性脑卒中后构音障碍患者为研究对象，随机分为治疗组和对照组，各50例。治疗组男29例，女21例；年龄47~90岁，平均年龄(68±11)岁；构音障碍严重程度：正常0例，轻度障碍20例，中度障碍13例，重度障碍17例，极重度障碍0例；言语功能评分8~21分，平均言语功能评分(15.5±3.9)分。对照组男25例，女25例；年龄38~89岁，平均年龄(64±13)岁；构音障碍严重程度：正常0例，轻度障碍20例，中度障碍20例，重度障碍10例，极重度障碍0例；言语功能评分9~21分，平均言语功能评分(16.3±3.1)分。两组患者性别、年龄等一般资料比较，差异均无统计学意义($P$>0.05)，具有可比性。

**1.2** 纳入标准 ①经临床头颅CT/磁共振成像(MRI)检查显示为缺血性脑卒中患者，首次或二次发病者均可，急性期、恢复期、后遗症期均可；②缺血性脑卒中后构音障碍患者；③通过Frenchay构音障碍评定量表评定为轻度以上构音障碍患者；④能配合治疗患者；⑤无器官功能衰竭，2周内无生命危险患者；⑥无慢性乙型肝炎(乙肝)、人类免疫缺陷病毒(HIV)等传染病患者；⑦无晕针史患者；⑧签署知情同意书患者。

**1.3** 排除标准 ①非脑卒中引起的构音障碍患者；②不能配合治疗患者；③有多器官功能衰竭，2周内有生命危险患者；④有乙肝、HIV等传染病患者；⑤既往有晕针情况患者。

**1.4** 治疗方法 两组患者均采用内科基础治疗，如营养脑神经，改善微循环，调控血压、血糖，中风二级预防措施等。对照组采用常规针刺(体针)治疗，根据患者病情辨证取穴治疗，隔1 d治疗1次，3次为1个疗程。治疗组采用舌咽四步针法治疗，操作方法：①咽后壁点刺：采用棉签(3支)稍用力按压舌后1/3处，暴露咽后壁，嘱患者发“啊”音，运用3寸无菌针灸针(用输液贴缠绕成双针)快速点刺咽后壁，一般5~7次，以咽后壁微出血或患者有恶心(呕吐反射)为佳；②舌面点刺：嘱患者放松，尽量将舌伸出口腔，用棉签(2支)固定舌面，在舌前2/3由舌部内向外以快速横向点刺，一般4~5排，每排3~4针，以舌面微出血为度；③舌底金津、玉液及舌系带快速深刺：嘱患者翘舌，用棉签(2支)将舌尖抬起，暴露舌底的金津穴、玉液穴和舌系带，快速深刺金津穴、玉液穴部位2次，在双侧舌系旁快速深刺，每侧1~2次，进针深度1.5~2寸，以微出血为宜；④舌三针：第一针为上廉泉穴，第二、三针为双侧上旁廉泉穴，其中上廉泉穴位于颈前正中，下颌骨下1寸处，上旁廉泉穴为上廉泉穴左右水平旁开1寸处，共3个穴位。用2寸无菌针灸针针刺上廉泉穴、上旁廉泉穴，舌根方向进针1.5寸，针柄呈扇形，不作行针手法；咽后壁点刺，舌面点刺，舌底金津、玉液及舌系带深刺不留针，舌三针留针30 min，隔日1次，3次为1个疗程。操作完毕，嘱患者坐起咳嗽，将口腔内血液及分泌物吐出，防止误吸。

**1.5** 观察指标及判定标准 比较两组患者构音障碍严重程度、治疗1个疗程后言语功能评分。Frenchay构音障碍评定表为临床上言语功能评定的常用工具，分为8个大项和28个细项，按损伤程度分为a、b、c、d、e共5级，其中a级为正常，e级为最严重，分别对应0~4分。根据28项中a项数/总项数评价患者构音障碍严重程度，其中(27~28)/28为正常，(18~26)/28为轻度障碍，(14~17)/28为中度障碍，(7~13)/28为重度障碍，(0~6)/28为极重度障碍。

**1.6** 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示，采用$t$检验；计数资料以率(%)表示，采用$\chi^2$检验；等级资料采用秩和检验。$P$<0.05为差异有统计学意义。

## 2 结果

**2.1** 两组患者治疗后言语功能评分比较 治疗后，治疗组言语功能评分为16~28分，平均言语功能评分为(26.2±2.4)分；对照组言语功能评分为9~28分，平均言语功能评分为(19.7±5.0)分。治疗后，两组患者言语功能评分均明显高于本组治疗前，且治疗组言语功能评分高于对照组，差异有统计学意义($P$<0.01)。见表1。

**2.2** 两组患者治疗后构音障碍严重程度比较 治疗后，治疗组构音正常31例，轻度障碍17例，中度障碍2例，重度障碍0例，极重度障碍0例；对照组构音正常5例，轻度障碍31例，中度障碍6例，重度障碍8例，极重度障碍0例。治疗组构音障碍严重程度轻于对照组，差异有统计学意义($P$<0.01)。见表2。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**表 1**　两组患者治疗后言语功能评分比较 ( $\bar{x} \pm s$, 分 )

| 组别 | 例数 | 治疗前 | 治疗后 |
|---|---|---|---|
| 治疗组 | 50 | 15.5 ± 3.9 | 26.2 ± 2.4[ab] |
| 对照组 | 50 | 16.3 ± 3.1 | 19.7 ± 5.0[a] |
| $t$ | | 1.135 | 8.287 |
| $P$ | | 0.259 | 0.000 |

注：与本组治疗前比较，[a]$P$<0.01；与对照组治疗后比较，[b]$P$<0.01

**表 2**　两组患者治疗后构音障碍严重程度比较 (n)

| 组别 | 例数 | 正常 | 轻度障碍 | 中度障碍 | 重度障碍 | 极重度障碍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗组 | 50 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 对照组 | 50 | 5 | 31 | 6 | 8 | 0 |
| $Z$ | | | | 5.605 | | |
| $P$ | | | | 0.000 | | |

注：两组比较，$P$<0.01

## 3　讨论

脑卒中是由于各种原因引起气血逆乱，如正气亏虚，饮食、情志、劳倦内伤等因素，从而产生风、火、痰、瘀，其基本病机为清窍脑脉痹阻，主要表现为突然昏仆、口舌歪斜、半身不遂、偏身麻木、言语謇涩或言语不能。其中言语謇涩为临床常见表现，主要就是构音障碍，祖国医学认为，由于风、火、痰、瘀等邪气阻滞心肾之经络，清窍受阻，进而阻闭舌窍，致舌窍失灵，咽喉失用而出现构音障碍，脑卒中后构音障碍的病位主要在咽喉与舌，涉及心、脑、肝、脾、肾等脏器。现代医学认为，舌和咽是发音的重要器官，其在生理病理机制方面均起着较为重要的作用。构音障碍就是由于构音器官的神经肌肉发生器质性病变，其严重程度与神经肌肉受损的程度呈正相关。当发生脑卒中时，尤其是脑干卒中时，由于中枢神经受损，支配构音的神经肌肉发生器质性病变，而发生构音障碍，由于构音器官在神经反射中属于感受器，用针刺刺激舌咽部，刺激感受器时中枢神经会受到反馈调节，从而能恢复功能，改善构音功能。中医认为舌与五脏六腑及经络有着密切联系，刺激舌咽部，可以调理经络脏腑气血，又可以通过经络穴位的近治作用达到治疗的目的。舌咽四步针法直接针刺咽部、舌体与舌底部穴位，间接针刺舌跟，采用刺激舌咽部为主的针刺方法改善构音器官的功能，达到调节气血，舒经通络的作用，从而治疗构音障碍。本研究采用舌咽四步针法治疗构音障碍，通过直接刺激构音器官、脏腑经络，出现神经反射的反馈，达到常规针刺治疗和药物治疗所达不到的效果。通过咽后壁的点刺，可以直接刺激舌咽部肌肉，产生舒缩运动，改善血液循环，产生反馈机制，使构音障碍患者的言语功能改善，功能恢复[4-6]。全身脏腑经脉与舌都有着直接和间接的联系，不少经脉循行都经过或联络舌，直接针刺舌体可以刺激与相关的经络脏腑，起到醒脑开窍、调理气血、通经活络之效；舌底金津穴和玉液穴属于经外奇穴，脏腑气血交聚，刺激具有活血经络之功。舌针治疗可以刺激末梢神经，促进神经反射，从而重建语言活动的神经环路，改善微循环，增加大脑供血，有助于脑组织功能的修复，改善语言功能[7-9]。舌针治疗后神经感觉冲动快速传至脑干网状结构，对脑源性疾病具有快速良好的调节作用[10]。

综上所述，舌咽四步针法能有效改善缺血性脑卒中后构音障碍患者言语功能，增强患者脑卒中后康复信心，使构音器官重新恢复正常，对患者预后及生活质量的提高具有重要意义。此方法操作简便、疗效显著，无明显毒副作用，患者接受度高，值得进一步临床验证和推广。

## 参　考　文　献


[1] 李胜利 . 言语治疗学 . 北京：华夏出版社，2004:77, 84.

[2] 郝盼富，徐秋利 . 点刺为主配合舌三针治疗脑卒中构音障碍的临床研究 . 中医药临床杂志，2017, 29(6):919-922.

[3] 贾力，白洁，刘冬 . 舌体分区多针点刺配合言语训练治疗脑卒中后运动性构音障碍 30 例 . 中国中医药现代进程教育，2016, 14(2):44-46.

[4] 赵甫刚，邢军，王亚辉，等 . 舌针、项针联合小组构音康复训练对脑卒中后构音障碍患者言语功能的影响 . 中国针灸，2018, 38(10):1080-1084.

[5] 李群，王祖红，叶建 . 舌针为主治疗中风临床观察 . 中国针灸，2005, 25(11):820.

[6] 孙雪然，孙介光 . 舌针疗法 ( 续 3)——功能磁共振在舌针研究中的应用 . 中国针灸，2010, 30(9):781-782.

[7] 赖清清，常青，谢晓华 . 舌面点刺法结合语言康复训练治疗缺血性卒中后构音障碍患者的临床效果 . 医疗装备，2022, 35(7):101-103.

[8] 沈秀玲 . 针刺联合言语治疗仪治疗脑卒中后构音障碍临床效果分析 . 临床医药文献电子杂志，2020, 7(10):55-56.

[9] 芮锦伟，区淑娟，权元鼎，等 . 圣愈汤联合针刺对缺血性脑卒中后失语症患者语言功能及生活质量的影响 . 现代中西医结合杂志，2020, 29(35):3920-3924, 3928.

[10] 钱小蕾，娄博 . 局部针刺结合言语康复训练治疗缺血性脑卒中后构音障碍的临床研究 . 中国保健营养，2021, 31(21):264.


［收稿日期：2022-11-23］

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net